



بطيركية الأقباط الأرثوذكس

أسقفية الشباب

قضايا طبية معاصرة:

تنظيم الأسـم

طفـل الأتـايـب

الاسـم تنسـخ

الأنبا موسى
الأسقف العام

الفهرس

رقم الصفحة

أولاً: تنظيم الأسرة

1 - المسيحية وتنظيم الأسرة. 7

2 - وسائل تنظيم الأسرة. 22

ثانياً: طفل الأنابيب

1 - فكرة طفل الأنابيب. 29

2 - مشروعية هذا العمل. 32

3 - انحرافات محتملة. 35

ثالثاً: الاستنساخ

38

حيث روح الرب هناك دائماً

1كو3:17



هناك قضايا كثيرة مثارة على الساحة العامة، بخصوص بعض الإنجازات العلمية، وموقف الدين المسيحي منها ومن بين هذه القضايا:

1- تنظيم الأسرة. 2- طفل الأنابيب. 3- الاستنساخ

ولا شك أن الأمور تحتاج إلى دراسة مستمرة ومتجددة، ففي كل يوم يقدم لنا العلم جديداً، ليس فقط في قضايا أخرى، لكن في نفس هذه القضايا.

لهذا فالدراسة المدونة في هذا الكتيب هي مجرد نظرة تمهيدية قابلة للفحص والنقد والمزيد من البحث والتعديل ... لكن هذا ما استطعت الاجتهاد فيه قدر إمكاني ... تاركاً للمتخصصين والعلماء والقيادات الكنسية فرصة التمحيص وإبداء الرأي.

إن كل ما نهدف إليه هو أن تكون الكنيسة واعية بقضايا العصر، وما يستجد على الساحات الفكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية، لتقدم لأبنائها وللجميع ما تراه المسيحية من جهة هذه الأمور.

الرب يعيننا في خدمة اسمه وكنيسته بصلوات راعينا الحبيب قداسة البابا شنودة الثالث.

ونعمة الرب تشملنا جميعاً،

الأنبا موسى

الأسقف العام

أولاً :

تنظيم الأسرة

المسيحية وتنظيم الأسرة

قد يتساءل البعض عن رأى المسيحية فى تنظيم الأسرة، وهل هذا تدخل فى إرادة الله ، أو معارضة للطبيعة الإنسانية أو عدم إيمان بأن الله قادر أن يرعى مواليدنا مهما كان عددهم؟ وهل هو مجرد مجاملة للدولة وهل يعنى ذلك التناقص المستمر فى عددنا كمسيحيين بالانقراض؟ وهل فى التناسل بلا حدود نوع من تجربة الرب ؟ وما هو الموقف من الآية التى تقول: " ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً " .. إذن فإذا كنت لا تريد أولاداً فلتمتنع عن العلاقة الزوجية!! وماذا عن أونان الذى كان "يُفسد فى الأرض حتى لا تحبل امرأته" (تك6:38-10)، فألمته الرب .. هل لأنه منع الحمل أم لأنه رفض أن يقيم نسلاً لأخيه؟

تساؤلات كثيرة حول قضية يومية وهامة، على مستوى الفرد (المرأة أو الطفل) والأسرة والكنيسة والمجتمع. وها نحن نرى الأمم يتزايد الفقراء فقرا مع تزايد معدلات إنجابهم بينما يزداد الأغنياء غنى مع تناقص لنسالتهم!! الأمر الذى يهدد البشر كأفراد وكدول وكأمن عالمى شامل أيضاً.

أولاً: ضرورة تنظيم الأسرة:

إذا كان الأنسال أحد أهداف الزواج فإن هذا لا يعنى أن نطلق له العنان دون تنظيم .. ونحن هنا نفرق بين "تنظيم النسل" و "تحديد النسل" فالتحديد يعنى الإنفاص باستمرار، ولكن التنظيم يعنى أن تتخذ كل أسرة قرارها الخاص حسب ظروفها الروحية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث يرتفع عدد الأولاد أو ينخفض طبقاً لظروفها الخاصة.

ولا شك أن تنظيم الأسرة ضرورة عامة، وضرورة خاصة.

1- الضرورة العامة:

كما أن المجتمع مسئول عن الأسرة والفرد، فالفرد والأسرة مسئولان عن المجتمع أيضاً .. هذا أمر هام يجب أن نتحدد ملامحه المسيحية فى وجداننا وذهننا!!

نعم الدولة مسئولة عن توفير الغذاء، والكساء، والدواء، والتعليم والإسكان وضروريات الحياة المنزلية كالأجهزة الكهربائية والإنارة، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحى، ووسائل الأعلام ... مسئوليات جسيمة تقوم بها الدولة نحو الوطن .. أفلا ندرك أن هناك مشاركة فى المسئولية من جهة المواطن بأن لا يتناسل بلا حدود فلا يضيف على الدولة أعباء لا طاقة لها بها؟! المنطق السليم: "إذا أردت أن تطاع، سل ما يستطاع" ومن غير المعقول أن تزداد مصر - مثلاً - مليوناً وثلاث نسمة سنوياً، ثم نقول للدولة: دبرى لهم كل احتياجاتهم السابقة!!

ماهى الدولة؟ هى مجموع المواطنين على رقعة أرض تنظمهم قوانين وتسوسهم قيادات منتخبة ... فماذا يمكن أن تفعل القيادات أمام الموارد المتاحة، إذا لم يبذل المواطنون جهودهم فى أمرين:

- أ- الإنتاج: الزراعى والصناعى والسلعى وغيره.
- ب- الإنسال المعقول الذى يتناسب مع هذا الإنتاج.

إن الضمير المسيحي يرفض أن نعيش حياة إقتصادية على الدولة دون أن نسهم بدورنا فى الإنتاج والانسال المعقول. ومعروف أن آية زيادة الآن فى الناتج القومى تأكلها الزيادة المخيفة فى السكان!! وبعد ذلك نقول: أين الدولة؟! نحن هنا لا نجمال الحكم، ولكننا نخاطب الضمير المسيحي، بل والضمير الإنسانى ... نحن نطالب بالمجانية وضبط الأسعار وضبط تكاليف الحياة...

ومن ناحية أخرى نتزايد بسرعة جنونية فهل هذا منطق؟ وهل هذا عدل؟ وهل هذه مسيحية حقيقية؟ أن نطالب الحقوق دون أن نقوم بالواجبات؟!

وفى هذا يقول **قداسة البابا شنودة الثالث**: «إن زيادة النسل أصبحت ضارة بالبلاد، فتحديد النسل بصورة عامة على المستوى القومى أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية، لها تأثيرها الكبير على مستقبل بلادنا لذلك علينا أن نتصدى لمشكلة الانفجار السكانى، الذى ينسف كل مشروعاتنا واقتصادنا القومى»

حجم المشكلة السكانية:

يقول رجال الإحصاء أنه عند اكتشاف الزراعة كان سكان العالم ما بين 5-8 ملايين نسمة.

✚ وعند ميلاد السيد المسيح كان سكان العالم 300 مليون

✚ وسنة 1600 ميلادية بلغ عددهم 450 مليون نسمة.

✚ وسنة 1800م أصبحوا 919 مليون نسمة.

✚ وسنة 1900م صاروا 1,7 مليار نسمة.

✚ وسنة 1950م أصبحوا 2,5 مليار نسمة.

✚ وسنة 1982م كان عددهم 4,8 مليار نسمة.

✚ وسنة 1992م صاروا 5,4 مليار نسمة.

✚ وسنة 1998م سيصل عددهم إلى 6,00 مليار نسمة.

✚ وسنة 2050م سيصل عددهم إلى 8,50 مليار نسمة.

وهكذا تضاعف العالم بين 1600 - 1800 م (200 سنة)

ثم تضاعف مرة أخرى ما بين 1950 - 1982 م (22 سنة)

وفى عام 2000 ستجاوز العدد 6 مليار نسمة.

فى مصر:-:-:-:-:-

* سنة 1800 - 44,2 مليون نسمة

* سنة 1900 - 10,00 مليون نسمة

* سنة 1950 - 20,00 مليون نسمة

* سنة 1960 - 26,00 مليون نسمة

* سنة 1978 - 40,00 مليون نسمة

* سنة 1989 - 52,00 مليون نسمة

* سنة 1993 - 56,50 مليون نسمة

* سنة 2000 - 75,00 مليون نسمة

* سنة 2013 - 143,00 مليون نسمة.

إذا كانت نسبة الزيادة فى العالم = 5,1 % سنوياً.

فإن نسبة الزيادة في مصر = 7، 2 % سنوياً.

نحن نزداد (في العالم) بمعدل 76 - 80 مليون نسمة أي 220 ألف كل صباح أغلبهم من الدول الفقيرة .. "حوالي 75 مليون في إجمالي 80 مليون".

أسباب الزيادة السكانية في مصر:

1- نقص معدل الوفيات:

- + سنة 1950: المواليد 43 في الآلاف والوفيات 19
- + سنة 1960: المواليد 39 في الآلاف والوفيات 16.
- + سنة 1970: المواليد 40 في الآلاف والوفيات 10.
- + سنة 1980: المواليد 39، 8 في الآلاف والوفيات 4، 9.
- + سنة 1991: المواليد 30، 8 في الآلاف والوفيات 5، 7.

2- الزواج في سن مبكر:

تقول الإحصائيات أن الريفي يرى في الزواج (سترة) ولذلك يسرع الريفيون في تزويج بناتهم (42% من فتيات مصر يتزوجن قبل العشرين والبعض قبل سن 14 ...) وحيث أن سن الإنجاب هو من 15-40 أو 45 يزداد عدد الأولاد في الريف...

إذ تقول الإحصائيات أن:

- + 20% من عائلات ريف مصر عدد أطفالها 6-8.
- + 40% من عائلات ريف مصر عدد أطفالها 9 فأكثر.

وفي المدن:

- + 40% من عائلاتها - عدد أطفالها أول من 5.
 - + 28% من عائلاتها - عدد أطفالها من 6-8.
 - + 25% من عائلاتها - عدد أطفالها 9.
- ومعروف أن الزواج المبكر مشكلة للزوج والزوجة حيث لا يقدرا مسؤولية الزواج وتربية الأطفال. والزواج المبكر لا يحمي الفتاة من الفساد، بل هناك الوعي والأمانة الروحية والتربية السليمة...

3- كثرة الأولاد عزوة ومعوونة:

يرى الريفي في كثرة الأولاد (عزوة) "أي مصدر قوة" ومعوونة في الحياة اليومية والزراعة.

4- كثرة الأولاد أمان للمرأة:

فهي خوفاً من الطلاق "تربط" زوجها بالأولاد، حتى لا يتجه نحو غيرها إذ يصير مسؤولاً عنهم طوال العمر.

5- تعدد الزوجات وكثرة الطلاق:

إذ يسفر عن مزيد من الأطفال.

6- انتشار الأمية خصوصاً لدى المرأة:

فلا يوجد وعي صحي أو تربوي مع جهالة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو حتى في مجرد الوعي بها وبأهميتها. كما أنهم لا يفكرون في تطوير حياتهم وتنمية أولادهم ثقافياً واجتماعياً بالطبع.

7- عدم توافر وسائل الترفيه في القرية:

أدى إلى أن تصبح العلاقات الزوجية هى الوسيلة المتاحة بدرجة أكبر وأسهل.

8- انخفاض مستوى المعيشة:

يجعل الزوجين غير قادرين على ضبط النسل، والرعاية الصحية والطبية اللازمة رغم جهود الدولة فى جعل كل ذلك نظير مقابل رمزى بسيط للغاية.

نتائج التزايد السكانى:

1- انخفاض دخل الفرد: كثرة العرض وقلة الطلب.

2- البطالة: استحالة استحداث أعمال لكل هذه الأعداد.

3- عدم كفاية الخدمات: الطعام والمسكن والملابس والمستشفيات والمدارس والمواصلات ... إذ ليس فى طاقة الدولة خدمة كل هذا العدد.

4- ضعف صحة المرأة: نتيجة جهد العمل والأبحاث والتربية ورعاية الأسرة والمنزل.

2- الضرورة الخاصة:

ونفصد بها ظروف كل أسرة فهناك أبعاد هامة يجب أن نضعها فى اعتبارنا اليوم بصفة عامة (لها إستثناءات قليلة)

(أ) جهد المرأة المعاصرة:

لا شك أن هناك فرق كبير بين الجهد الجسمانى والعصبى للمرأة المعاصرة والمرأة منذ 50 سنة ... فالمرأة المعاصرة عاملة تقضى نصف اليوم وربما أكثر فى عملها، وعمل المرأة أصبح واقعاً عصرياً لا يهم فقط اقتصاديات الأسرة لكن اجتماعياتها وأسلوب تربيتها لأنائها كذلك فالمرأة المعاصرة ليست فى القوة البدنية التى كانت للمرأة منذ نصف قرن .. وذلك بسبب ضغوط الحياة والتعليم والمجتمع والأعلام .. الخ.

لذلك لا تستطيع المرأة المعاصرة إنجاب الكثير من الأطفال دون تأثير بالغ على صحتها الجسدية والنفسية والروحية وعلاقاتها بالمجتمع وحركة الحياة.

(ب) جهد التربية المطلوب:

بل إنها بالقطع - لا تستطيع مع زوجها المشغول بالعمل فترتين أحياناً كل يوم، أن تربي أولادها حسناً لو ازداد عددهم، سواء من جهة حياتهم المدرسية أو الروحية أو الاجتماعية أو حتى الصحية.

إننا لا يمكننا أن نحمل المرأة أحمالاً عسرة الحمل دون أن نحركها بأحد أصابعنا ... الأمر الذى سبق ولنطبق على الدولة أيضاً

فإن كان الرب سيسألنا عن أولادنا وما قمنا به نحوهم من جهد تربوى روحى ونفسى واجتماعى فمن العدل والمنطق أن نكتفى بعدد قليل من الأولاد، نحسن رعايتهم وتربيتهم فليس المهم (كم) الأولاد ولكن المهم (كيفهم) ... وقديماً قال الحكيم: "لا تشته كثرة لا خير فيهم ولا تفرح بالبنين المنافقين ولا تسر بكثرتهم إذا لم تكن فيهم مخافة الرب" (أم خ 1:16) ... "ولد واحد يتقى الرب خير من ألف منافقين" (أم خ 3:16)

أضف إلى جهد التربية الروحية جهد التربية التعليمية والنفسية للأولاد إذ يحتاج الوالدان لرعاية أبنائهما دراسياً ومساعدتهم فى الواجبات المدرسية الثقيلة خصوصاً مع ضعف التحصيل المدرسى الآن.

(ج) الجهد الاقتصادى المطلوب:

فلا شك أن الظروف الاقتصادية الآن تجعل تكلفة رعاية الطفل اكبر بكثير مما مضى، سواء فى الحمل أو الولادة أو الرضاعة أو التغذية أو التعليم أو الصحة أو التربية الجسمية والذهنية والنفسية والاجتماعية.

الطفل الآن لابد من دخوله الحضانة منذ السنوات بل ربما الشهور الأولى من ميلاده، حتى يفتح ذهنه ويصير كأفرانه قبل دخوله إلى المدرسة قادراً على التعلم واللعب والتفاعل والنمو الذهني والتحصيل الدراسي وإلا تعرض لإحباط رهيب لو أنه خرج من البيت إلى التعليم الإبتدائي مباشرة إذ يرى نفسه أول من أفرانه في أمور كثيرة.

ماذا أيضاً عن مصاريف التعليم والملبس اللائق والسكن والصحة والمواصلات ... مجرد بند الدروس الخصوصية أصبح رهيباً ومن العسير التخلص منه ليس فقط بسبب احتياج الطفل والشاب لعدم كفاءة العملية التعليمية لأسباب مختلفة أهمها تكدر الفصول، ولكن لأسباب نفسية إذ يرى الطالب نفسه غريباً عن أفرانه فالجميع يأخذون دروساً خصوصية وهكذا يخاف أن يتخاف عنهم فيأخذها بدافع نفسى محض في كثير من الأحيان.

ماذا عن تكدر السكن، الذى صار الآن محدود المساحة جداً .. كيف يتنفس الأولاد وكيف يتحركون ويلعبون؟! هذا ضار جداً بنفسية الأجيال الصاعدة، وبحياتهم الأسرية والمجتمعية!!

إن بند (الألعاب الذهنية) المطلوبة للأطفال أصبح يحتاج الكثير من المال، وكذلك إمكان اشتراكهم فى نواد جيدة تبنى أجسادهم وأعصابهم ونفوسهم وعلاقاتهم ..

وها قد تأخر سن الزواج وأصبح الأولاد والبنات يستمرون فى بيت الأسرة لسنوات طويلة وينتظرون من الوالدين إسهاماً فى تكاليف الزواج الرهيب التى كثيراً ما تستعصى عليهم.

د- تناقص نسبة الوفيات:

كانت الأمهات - فى الماضى - يلدن العديد من الأطفال، وكانت نسبة وفيات الأطفال مرتفعة جداً، أما الآن وبسبب الرعاية الصحية والتعليم انخفضت هذه النسبة للغاية لذلك فإن كان تنظيم الأسرة غير مناسب فى الماضى لوفاة أكثر من نصف الأولاد إلا أنه أصبح ضرورة وإلا شاهدنا انفجاراً سكانياً رهيباً .. بالإضافة إلى متاعب التربية بمشتملاتها. أمام هذه الضرورات العامة والخاصة، كان لابد من تنظيم الأسرة لنحصل على النسل الصالح الذى يمجداً ، ويهتم بخلاص نفسه ويشهم فى بناء وطنه شهادة للمسيح وحملاً للأمانة.

ثانياً: تساؤلات واعتراضات:

هناك تساؤلات كثيرة واعتراضات تواجه موضوع تنظيم الأسرة يجب أن نضعها فى اعتبارنا:

(1) هل يتعارض تنظيم الأسرة مع الإيمان؟

وهذا السؤال له عدة فروع:

أ- هل فى تنظيم الأسرة تدخل فى مشيئة ا ؟

ب- وهل فى تنظيم الأسرة رفض لعطية ا ؟

ج- وهل فى تنظيم الأسرة شك فى سخاء ا ؟

أ- تنظيم الأسرة ومشية الله:

إن تنظيم الأسرة لا يعنى التدخل فى مشيئة ا ، حينما نمنع تكوين الجنين لضرورات عامة وخاصة كنتك التى ذكرناها بل بالعكس، إن وسائل تنظيم الأسرة أو حتى مجرد اكتشاف فترة الأمان وضبطها علمياً هى إنجازات علمية طيبة بسماع من ا حينما رأى برعايته وحنانه أن الإنسان تقدم علمياً وضعف جسمياً وعانى اقتصادياً واجتماعياً وعصياً.

وما بمننا نسمح بعلاج العقم والعقر ولا نعتبر ذلك تدخلاً فى مشيئة ا طالما أننا نستخدم وسائل لا تتعارض مع الدين فلماذا لا نستخدم الطب والوسائل العلمية فى ضبط النسل مراعاة للصحة الخاصة والعامة؟

وما بمننا لا نعتبر العقم سبباً لطلاق والنسل شرطاً لصحة الزواج، فلماذا لا نعتد صحة الزواج بنسل محدود مع

تحقيق الأهداف الأخرى مثل الحب والتعاون وخلص النفس وخلق المزيد من القديسين؟

إن وسائل تنظيم الأسرة نوع من الاستشفاء الفردى والأسرى والمجتمعى، والإيمان با لا يلغى استخدام الطب والعلوم المختلفة لإسعاد الفرد والأسرة والمجتمع.
ب- تنظيم الأسرة وعطية الله:

نحن لا نرفض عطية ا حينما ننظم الأسرة ولكن العقل لا يتعارض مع الإيمان، والاهتمام بمسئولية التربية والرعاية الروحية والدراسية والصحية والنفسية لا يتعارض مع استخدام هذه الوسائل للحصول على نسل قوى بدنيا وصحيح نفسيا ومقدس روحيا، بل إن ا فى عطياه يعطى كل واحد "على قدر طاقته" ... " فأعطى الواحد خمس وزنات والآخر زنتين، والثالث وزنة واحدة" (مت 15:25) فهل من حق الثالث أو من واجبه أن يطلب من الرب عشر وزنات أكبر من طاقته؟!

الأمر لا يعدو تقدير المسئولية وذلك بالتشاور مع الأب الروحى ودراسة الإمكانيات الاقتصادية والسكنية والصحية والروحية .. الخ.

ج- تنظيم الأسرة وسخاء الله:

هل نترك أنفسنا لسخاء ا وإمكانيات الطبيعة الإنسانية فى إنجاب العديد من الأولاد ونقول أن ا السخى فى عطاء الأولاد سخى فى عطاء القوة والرزق؟ ألا يعتبر هذا نوعا من "تجربة الرب" "لا تجرب الرب إلهك" (مت 7:4)؟! وألا نرى فى ذلك نوعا من "تغيب العقل" الوزنة التى أعطاها لنا الرب لتبوير أمورنا؟! كذلك ألا يكون فى ذلك نوعا من التواكلية وليس الاتكال؟! ألا نؤمن بضرورة توافق الجهاد والنعمة فى أمر خلاصنا بل حتى فى أمور حياتنا اليومية؟!

2- هل يتعارض تنظيم الأسرة مع الطبيعة؟

يتصور البعض أن تنظيم الأسرة ربما يتعارض مع الطبيعة ويتخذون ذريعة لذلك أمرين:

أ- قصة أونان ... ب- آية الزرع والحصاد

أ- قصة أونان:

وهى القصة المذكورة فى (تك 6:38 - 10) كيف انه رفض أن يقيم نسلاً لأخيه فكان حينما يجتمع بزوجة أخيه المتوفى يفسد فى الأرض، فأمرته الرب! وواضح أن هذه القصة لا تنطق على استخدام وسائل تنظيم الأسرة حيث أن خطيئة هذا الرجل لم تكن فى منع الحمل، ولكن فى رفضه أن يقيم نسلاً لأخيه، وهى وصية إلهية مشهورة فى العهد القديم وخاصة بالمواريث والأسباط، لذلك فاستخدام قصة أونان هو نوع من خاٹ الأوراق دون داع أو مبرر.

ب- آية الزرع والحصاد:

إذ يتذرع البعض بالآية التى تقول: "الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً" (غل 6:7) فيقولون: " ما دمت لا تريد نسلاً امتنع عن العلاقة الزوجية!! وهذا خاٹ خاٹى فالآية تتحدث عن عموميات السلوك اليومى والحياة الإنسانية ولا تقصد إطلاقاً العلاقة الزوجية والتناسل بدليل:

■ هل لابد أن يمتنع الإنسان بمجرد حدوث الحمل؟ بل حتى اكتشاف الحمل يأخذ أياماً، فماذا عن المعاشرات التى تلت لقاء الحمل؟

■ وهل نحرم العلاقات الزوجية فى حالة عقم الزوج، أو عقم الزوجة؟

■ وهل نحرمها فى حالة استئصال الرحم أو ربط قناتى فالوب أو غير ذلك؟

■ وهل نحرمها فى سن اليأس؟

إن العلاقة الزوجية هى: + إحتياج بيولوجى + وتعبير حب مقدس.

"المضجع طاهر" (عب 13:4) ورابطة الزواج رابطة حب وليس فقط تناسل، وإلا رفضنا العلاقات في حالة العقم بل صرحنا بالطلاق في هذه الحالة، الأمر الذي يرفضه الرب.

3- هل يتعارض تنظيم الأسرة مع وصايا الله؟
قد يتساءل البعض، ألم يقل ا لآدم وحواء وأولادهم: **اُثمروا واكثروا واملأوا الأرض** (تك1:28) .. إذن فهل يتعارض تنظيم الأسرة مع هذه الوصية؟

الإجابة البسيطة تقول: نحن لا نأخذ آيات الكتاب فرادى، فهناك خطر الاعتماد على الآية الواحدة كما علمنا **فداسة البابا شنودة الثالث** هناك آيات أخرى تحضنا على: الحكمة، والتربية الحسنة للأولاد فلماذا نتجاهل ضرورة الدرس والتفكير واستخدام العقل المسـتنير بالروح القدس في تدبير أمور حياتنا، تحت الارشاد الروحي السليم؟!
فماذا عن وصية (لا تقتل)؟ الإجابة طبعاً أننا نرفض الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة، كما نرفض أية وسيلة تقتل الجنين نحن نمنع تكوين الجنين، دون أن نقتله .. إذن فلا كسر لوصية "لا تقتل"

يردد البعض ما جاء في **"الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية"** للقمص فيلوثاؤس، وكذلك في القوانين التي جمعها ابن العسال وكيرلس ابن لفاق أن لا يجوز للرجل، إذا أتى زوجته، أن يعزل عنها باستخراج الزرع وإلقائه بفصد عدم حصول النسل، أو لأى قصد كان، ولا يجوز التداوى لمنع الحمل فإن هذين الشرين ضد الناموس المسيحى وذلك استشهاده بقتل أونان بن يهوذا.

وقد سبق أن أوضحنا خطيئة أونان وهى عدم رغبته فى إقامة نسل لأخيه المتوفى، وليس فى منع الحمل، ونضيف أن الكلام السابق، وفى كلام ذهبى الفم أيضاً، التحريم هنا ينطبق على **"منع الحمل بصورة مطلقة"** إذ يقول ذهبى الفم: **"حتى لا نكون لطبيعتهم ثمرة"** وهذا يختلف عن تنظيم الأسرة طبعاً، كما أن الكثير من القوانين كانت لظروف اجتماعية معاصرة، كحدوث أوبئة أو حروب وللكنيسة فى كل عصر أن تدرس ظروفه وتقنن له فى حدود الكتاب المقدس والقوانين العامة المستقرة والتقليد الرسولى الكنسى وإجماع الآباء.

4- هل يتعارض تنظيم الأسرة مع الصحة؟
نحن لا نقبل - بالطبع - أية وسيلة لتنظيم الأسرة يكون فيها أضرار بصحة الأم أو الأب ... بل إن كل الجهود الطبية تحرص على بلوغ هذا الهدف منع الحمل، دون إضرار بصحة الوالدين؟
ولهذا أيضاً نوصى بالتشاور مع الطبيب المختص، لاختيار الوسيلة المناسبة دون المساس بصحة الوالدين قدر الإمكان فى حدود علم البشر ومعطيات البحوث الحديثة.

شروط التنظيم السليم للأسرة:

- 1- مراعاة الضرورة العامة.
- 2- مراعاة الظروف الخاصة.
- 3- عدم قتل الجنين.
- 4- عدم الأضرار بصحة الزوجين.

(2)

وسائل تنظيم الأسرة

هناك وسائل كثيرة لتنظيم الأسرة، نورد بعضاً منها تاركين التفاصيل العلمية لأهل التخصص ...

كيف يحدث الحمل؟

- ⊗ يفرز المبيضان بويضة كل شهراً بالتبادل.
 - ⊗ تلتقط الأهداب - فى آخر قناة فالوب - البويضة، وتسير البويضة فى القناة.
 - ⊗ إذا حدث إخصاب للبويضة يتم ذلك فى قناة فالوب ويبدأ تكوين الخلية الأولى للجنين ثم انقسام وتكاثر الخلايا.
 - ⊗ تندغم البويضة المخصبة (النواة الأولى للجنين) فى بطانة الرحم، لتكون جنيناً بعد ذلك.
 - ⊗ تبدأ المشيمة فى إفراز الهرمونات التى كان المبيض يفرزها قبلاً وذلك يمنع التبويض (الاباضة) مما يتسبب فى توقف الدورة الشهرية أثناء الحمل.
 - ⊗ إذا لم يحدث إخصاب للبويضة فى قناة فالوب تسير نحو الرحم ثم تندفع إلى الخارج مع بطانة الرحم التى تضعف وتتفشر وتنزل مع بعض الدماء (الدورة الشهرية) ... والسبب أن عدم الإخصاب ينتج عن انخفاض فى إفراز هرمون البروجستيرون Progesteron، والمسئول عن تثبيت بطانة الرحم تحسباً للإخصاب والحمل.
 - ⊗ يبدأ المبيض الآخر فى العمل لتنمو بويضة جديدة يفرز منها هرمون الأستروجين Estrogen الذى يبدأ فى تكوين بطانة البروجستيرون الذى يثبت بطانة الرحم انتظاراً للإخصاب فإذا لم يحدث إخصاب تقل نسبة البروجستيرون فتضعف بطانة الرحم وتتفكك وتنزل مع البويضة غير المخصبة وبعض الدماء .. وهكذا.
- أولاً: وسائل منع الحمل " للنساء ":

هناك أنواع مختلفة مثل:

(أ) الوسائل التقليدية: (غير المضمونة)

1- **الجماع المقطوع:** (أى عدم وصول السائل للرحم)

2- **الرضاعة:** تقلل احتمالات الحمل ولكنها غير مضمونة.

3- **الحواجز المصنوعة فى البيت:** قطع قماش أو إسفنجة نظيفة، مبللة بمحاليل مبيدة للحيونات المنوية كالخل أو

الماء المالح أو الليمون أو أحد أنواع الزيوت .. تربط بخيط داخلى متين ليسهل إزاحتها بعد الجماع .. ويدخل إلى

عقن المهبل فى حدود ساعة قبل الجماع وهى طريقة غير مضرة عموماً، لكنها غير مضمونة.

4- **فترة الأمان:** فى الدورة الشهرية توجد ثمانية أيام خصبة تكون فيها البويضة قابلة للتلقيح، وتسمى فترة الأمان،

حيث يمكن أن يتباعد الزوجان فلا يحدث حمل.

تحسب هكذا: من اليوم الأول للدورة الشهرية حتى اليوم العاشر: أمان ... ومن الحادى عشر إلى الثامن عشر: إخصاب ممكن وبعد ذلك أمان.

إذا كانت الدورة غير منتظمة تحسب فترة الأمان هكذا: نطرح رقم 11 من أطول دورة (20 يوم مثلاً) ورقم 18 من أقصر دورة (28 يوم مثلاً) وتكون فترة الإخصاب من اليوم 10 - 18 يتم التباعد.

المشكلة: سهولة حدوث خطأ فى الحساب ... ومشكلة أخرى عدم ضمان الانفعالات والابتعاد التام فى هذه الأيام (فترة الأمان) فيحدث حمل.

ب- الوسائل الحديثة (المضمونة بدرجة جيدة)

1 - الأقراص: (Contraceptive Pills)

الفكرة: أن نزيد من هرمون الأستروجين لمدة 11 يوماً ثم البروجسترون لمدة 10 أيام هذه الزيادة توقف إشارات المخ، لإفراز الهرمونات التي تحث المبيض على الإباضة فلا يفرز بويضات من الأساس بالإضافة إلى تثبيت بطانة الرحم، مما يجعل افرازات عنق الرحم سميكة، لمنع مرور الحيوانات المنوية إلى الرحم.

موانع الاستعمال: الجلطة وأمراض الشرايين، الكبد، ارتفاع الضغط، السكر، أورام الثدي، أورام الرحم، اضطرابات الغدد عموماً، تقدم السن بعد 35 عاماً أمراض القلب، الرضاعة، أزمت الربو.

مخاطرها: نادراً ما يحدث جلطة أو يرقان أو سرطان بالثدي.

الأعراض الجانبية: تورم الثديين - الدوخة تغير في كمية الدم عند الحيض - زيادة في الوزن ... وهى أمور غير خطيرة مع الرعاية الطبية.

- ينصح دائماً بأخذ فترة راحة لمدة شهر أو شهرين كل عام لتنشيط المبيض ليعمل.
- ولا يستمر إعطاؤها بعد سن 35 لحدوث أضرار بعد هذا السن. لابد من فحص باطنى (السكر، الضغط، الكلى، الكبد) قبل أخذ الأقراص لمنع حدوث مضاعفات.
- نسبة حدوث أورام مع استخدام الأقراص أقل من نصف فى المائة.
- أحياناً تنسى الزوجة الانتظام فى أخذ الأقراص فيحدث حمل، وهى وسيلة مضمونة إلى حد كبير جداً لمنع الحمل.

2 - اللولب: (Intra - Uterine Devices) (IUD).

- عبارة عن قطعة بلاستيكية أو معدنية (نحاس أو فضة) تدخل إلى الرحم فتمنع حدوث الحمل.
- يـول الكثير من العلماء أن طريقة اللولب فى منع الحمل غير معروفة بدقة فهو قد يؤثر فى الحيوان المنوى، أو البويضة أو الإخصاب أو الاندغام فى بطانة الرحم أو فى بطانة الرحم نفسه.
- يعمل اللولب كجسم غريب داخل الرحم يحدث فيه توترات وتقلصات مستمرة يمكن إن تمنع وصول الحيوان المنوى إلى البويضة، أو تعجل بخروج البويضة المخصبة أن تكونت، أو يتسبب فى ضعف حيوية الحيوانات المنوية بما يفرزه من مواد كيميائية.

- اللولب له ميزات كثيرة، إذ أنه لا يحتوى على الهرمونات ولا يؤثر على الرضاعة ولا يسبب أية أورام ويسهل اللغاء الزوجى دون حسابات ويستمر فى الرحم حتى ستة أعوام حينما يتم تغييره بآخر، ولكن له عيوب أيضاً إذ يتسبب فى التهابات بالحوض أو نزيف وأحياناً يخترق جدار الرحم كما أن نسبة الحمل فيه تكون من 3-5%.

السؤال المهم: هل يتكون جنين ويجهض فنكون قد وقعنا فى خطأ؟ الحقيقة ممكن أن يتكون الجنين فى حالات قليلة لذلك ينصح الطبيب المتدين باستخدام وسيلة مصاحبة مع اللولب مثل:

أ - فترة الأمان: فنضمن عدم وجود بويضة أصلاً.

ب - وسيلة موضوعية: فى الفترة المتوسطة (فترة الإخصاب) (10 - 18 يوماً من الدورة) سواء تستخدمها السيدة أو الرجل لمنع تكوين جنين. وبذلك نتقى - قتل جنين.

- حمل داخل الرحم - حمل فى قناة فالوب يحتاج إلى جراحة.

3 - الحقن: (Injectable Contraceptives)

وهى عبارة عن هرمون البروجسترون، بتركيز معين، مختلط مع زيوت، للحقن العضلى، وتنصرف بمعدل ثابت يومياً بالجسم، لمدة ثلاثة أشهر. وهى أقل ضرراً للجسم من الأقراص. تمنع التبويض بنسبة 20% ونسبة حدوث الحمل 1-2%. تعمل عن طريق عنق الرحم، لزيادة افرازاته لتكون سميكة جداً بحيث تمنع مرور الحيوانات المنوية، إذ يكون عنق الرحم مغلقاً تماماً، وممثلًا بهذه الافرازات السميكة فيصبح بمثابة حاجز طبيعى.

يختار الأطباء هذا الأسلوب لبعض الحالات التي لا يصلح لها استخدام الأفراس: السكر، الضغط، الربو، أورام الثدي .. تؤخذ مع الرضاعة (رغم أن البعض يخاف منها كإحساس شخصي). لها بعض المضاعفات مثل الاضطراب، والنزيف الرحمي، وانقطاع الدورة بعد زوال مفعولها وهذه يسهل علاجها. استخدمت في حوالي 80 دولة معظمها في أفريقيا (للادراسة) وهي أحياناً تضر بالجنين أو الطفل وتزيد من نسبة حدوث سرطان الثدي والرحم. يرى الأطباء أن استخدامها مرة أو مرتين ممكن، لحين استخدام وسيلة أخرى ومع ضرورة المتابعة الطبية طبعاً.

4- الحجاب الحاجز: (Diaphragm)

- حاجز من المطاط يغلق عنق الرحم.
- وسيلة فعالة ومضمونة، خصوصاً إذا استخدمت مع من هم يبيد الحيوانات المنوية.
- يستخدم قبل ساعتين من الجماع ويحتفظ به 8 ساعات بعده.

5- الوسائل الكيميائية:

- مرهم أو سائل أو أفراس موضعية للسيدات، لقتل الحيوانات المنوية.
- تستخدم ساعة قبل الجماع ويجب أن تبقى 6 ساعات بعده.

6- ربط فنتلي فالوب:

- بموافقة الزوجين خصوصاً بعد إجراء أكثر من قيصرية أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد.
- ممكن إعادة فتحها فيما بعد ولكن كثيراً ما تحدث إلتصاقات صعبة الإزالة.
- ثانياً: وسائل منع الحمل "للرجال":

1- الواقي الذكري: (Condoms)

- فكرته منع وصول الحيوانات المنوية للرحم.
- لا خطر فيه على صحة الرجل أو المرأة.
- وسيلة فعالة ومضمونة.

2- قطع فنتلي المنى: (Vasectomy)

- لا يؤثر على القدرة الجنسية للرجل.
- لا بد من التأكيد من عدم إرادة الإنجاب نهائياً.

3- هرمونات:

- تمنع تكوين الحيوانات المنوية نهائياً.
- منها الحقن مثل (Depot Provera)
- وأفراس من مصدر نباتي لمنع تكوين الحيوانات المنوية، أو منع حركتها.

ملاحظات هامة:

- 1- لا بد من الفحص الطبي الدقيق قبل اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة.
- 2- لا بد من المتابعة الطبية المستمرة.
- 3- لا بد من التروى في القرارات التي ستستخدم الجراحة.
- 4- يمكن عموماً السير هكذا:

أ- من الزواج إلى الرغبة في الإنجاب: يستخدم العازل الطبي (الواقي الذكري أو الحجاب الحاجز) وليس الهرمونات أو اللولاب.

ب- في فترة الرضاعة: اللولاب أو العازل الطبي، مع تجنب الهرمونات.

ج- **الفترة الأخرى:** يمكن استخدام الأقراص لمدة ثلاثة أشهر ثم وسيلة موضوعية أو عازل طبي .. وهكذا.
ويمكن اخذ الحقن مرة أو مرتين فى العام حتى سن 35 وبعد ذلك اللولب مع العازل (من اليوم العاشر إلى اليوم 18) أو التباعد فى هذه الفترة.

ثانياً :

على الأنابيب

* فكرة طفـلـ الأنابيبـ.

* مشروعية هذا العمـلـ.

* انحرافات محتمـلـةـ.

1 = فكرة طفل الأنابيب:

إن فكرة طفل الأنابيب تعتمد على أخذ البويضة من الزوجة بعد إجراء فحوص طبية تؤكد سلامة جسمها ومبيضها ومعرفة موعد الإباض وفحص الدم وملاحظة درجة حرارة الجسم ... عند خروجها من المبيض، بواسطة مسبار (Laparoscope) خاص، يدخله الطبيب في جوف البطن تحت التخدير الكلى، عند موعد خروج البويضة من المبيض، فيلتقطها، ثم يضعها في طبق يدعى طبق بيتري Petri Dish (وليس في أنبوب كما هو شائع) .. وفى هذا الطبق سائل فسيولوجى، مناسب لبقاء البويضة ونموها.

ثم يؤخذ المنى من الزوج بعد 4-6 ساعات، ويوضع فى الطبق مع البويضة وحين يتم تلقيح البويضة الملقحة لتتقسم انقساماتها المعروفة المتتالية، إذ تصير الخلية خليتان ثم أربعة ثم ثمان وتنتقل البويضة الملقحة (الزيجوت) لتصير فى مرحلة التوتة Morula إذ تشبه ثمرة التوتة ... وهذه سرعان ما تتحول إلى ما يعرف بالكرة الجرثومية Blastula، التى يحدث فى داخلها تجويف، يمتلئ بسائل، ثم توضع هذه الكرة فى جدار الرحم، حيث تنغرز فيه، وتنمو نمو الحمل الطبيعى، حتى الولادة.

والمدة التى تبقى فيها البويضة فى الطبق لا تعدو يومين أو ثلاثة ... وفى حوالى 90% من الحالات يلفظ الرحم هذا الجنين إذ ينقبض بشدة حينما يدخل الطبيب المسبار حاملاً هذا الجنين الصغير .. الأمر الذى يستدعى المهارة والدقة كما أن نجاح غرز الجنين فى الرحم لا يمنع إجهاضه فى الثلاثة أشهر الأولى فى 32% من الحالات وكلما زاد عمر المرأة زاد احتمال الإجهاض.

لماذا نلجأ إلى هذه الفكرة أحياناً...

يلجأ الأطباء إلى هذه الفكرة لأسباب متعددة مثل:

1 - انسداد قناة فالوب:

وهى القناة التى تربط الرحم بالمبيض، وتنتهى بأهداب ... وحينما تخرج البويضة من المبيض تلتقطها الأهداب التى فى طرف قناة فالوب، وتحملها داخلها وتحركها نحو الرحم ... وفى الأوضاع الطبيعية يلتقى الحيوان المنوى Spermatozoq بالبويضة فى منتصف قناة فالوب، ويلفحها، وتنقسم البويضة الملقحة عدة مرات، ثم يتحرك هذا الجنين الصغير جداً من قناة فالوب ليزرع فى جدار الرحم، حيث ينمو إلى جنين كامل حتى إلى يوم الولادة.

إن هذا الانسداد فى قناة فالوب يمنع تلاقى الحيوان المنوى القادم من الرحم، ثم القناة مع البويضة القادمة من المبيض ثم القناة ... وكل ما يفعله الطبيب لتلافى هذا العائق .. أن يجمع الحيوان المنوى مع البويضة فى طبق خارجى

مناسب ثم يزرع الجنين الصغير فى جدار الرحم ... وهكذا نتخطى هذا الحاجز أو العائق الموجود فى قناة فالوب وفى العادة يحاول الأطباء إزالة العائق جراحياً فى قناة فالوب لكن نجاح العملية يكون من 1-70%.

2- فلة الحيوانات المنوية:

بحيث لا تزيد عن مليون أو ربما أقل، مع فشل محاولات التلقيح الاصطناعى الداخلى Artificial Insemination ومع هذا فنسبة النجاح لا تزيد عن 20% إذا كان عدد الحيوانات المنوية أقل من 10 مليون فى المليمتر وأقل من ذلك كلما قل عددها.

3- إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية:

مما يسبب هلاكها وقد ينجح فى هذه الحالات التلقيح الاصطناعى الداخلى .. فإذا فشل لجأنا إلى التلقيح الاصطناعى الخارجى (طفل الأنابيب) .. وذلك مع نسبة فشل كبيرة بسبب هذه الإفرازات، إلا إذا كان هناك أجسام مضادة تساعد على إتمام التلقيح.

4- انتباز بطانة الرحم Endometriosis

حيث تظل الأنابيب مفتوحة، لكن عملها قد يعطل .. وتكون نسبة النجاح 20% حينما نلجأ لفكرة الأنبوب ولكن فى حالات الانتباز الشديدة تقل نسبة النجاح.

5- حالات العقم غير معروفة السبب ...

فرغم كل الفحوصات فى المراكز المتقدمة، تظل بعض حالات العقم غير معروفة السبب .. ونسبة نجاح طفل الأنابيب هنا ممكنة وإن كانت ضئيلة...

لويزا براون:

أنها أول طفلة أنابيب فى التاريخ ... فلقد أخذ الدكتور باتريك إستيتو بويضة الأم ليزلى براون يوم 10 نوفمبر 1977، ووضعها فى الطبق الذى حضر محلوله الدكتور روبرت إدوارد .. وبعد أن قلما بتلقيح البويضة من ماء زوجها، أعادها د. إستيتو إلى رحم الأم فى 12 نوفمبر .. وفى 25 يوليو 1978 ولدت الطفلة ليزا براون فلتحة أول صفحة فى تاريخ التناسل البشرى بطريقة الأنابيب.

2- مشروعية هذا العمل:

الموضوع إذن بسيط وواضح نحن لا نفعل شيئاً سوى نخطفى العائق الموجود فى القناة .. فطالما أن:

- 1- الحيوان المنوى هو من الزوج والبويضة من الزوجة ... وليس من أى مصدر آخر خارجى...
- 2- لا يحدث قتل لأى جنين مهما كان صغيراً ... إذن ... فنحن لا نفعل خطأ، ولا يرفض الدين هذا العمل الطيب .. فالدين لم ولن يعارض أى علاج للعقم، طالما أنه لا يحدث اختلاطاً بالأنساب، أو يكون فيه شبهة من جهة مصدر الحيوان المنوى والبويضة أو يكون فيه قتل للأجنة مهما كانت صغيرة.

ولكن ... هناك ملاحظات كثيرة وهامة يجب أن نأخذها فى الاعتبار:

إن 90% من محاولات الأستيلاد بطريقة الأنابيب تفشل، وذلك لصعوبات كثيرة منها:

- 1- معرفة موعد خروج البويضة أو البويضات من المبيض ... وهذا يستدعى إعطاء المرأة مجموعة من العقاقير أشهرها الكلوميدي Clomide، التى تجعل المبيض يفرز عدداً من البويضات فى الشهر الواحد، بدلاً من بويضة واحدة وذلك مع دراسة كاملة للأم لمعرفة موعد الإباض، حتى يتم إدخالها للمستشفى فى الوقت المناسب، وإدخال منظار البطن، ورؤية المبيض، ثم إلتقاط البويضات، وهذه عملية فنية دقيقة تكتنفها صعوبات كثيرة، نتيجة التهابات القناة وما حولها أو التهاب سابق بالمبيض أو وجود تليف ... الخ.

2- بعد أن يتم شفط البويضات وتوضع فى محلول فسيولوجى مناسب لنموها ... وهذا المحلول يحتاج تركيبه إلى مهارة فنية عالية.

3- تلقيح البويضات وملاحظة مرورهن بمراحل النمو، حتى يصلن إلى مرحلة التوتة Morula ثم الكرة الجرثومية Blastula.

4- إعادة غرز البويضات فى الرحم ... وعادة توضع أكثر من بويضة ملفحة بالرحم، لأن الرحم عادة يلفظ البويضات ... وكلما زاد عدد البويضات المغروزة فى الرحم، كلما زاد احتمال نجاح واحدة منهن، فى النمو إلى مرحلة الجنين ثم الولادة .. وقد يحدث أن تنتج عدة بويضات فى التلقيح والنمو ... وهكذا نحصل على عدة توائم، وقد يحمل هذا مخاطر للأم ولالأجنة معاً...

5- عادة ما يترك الطبيب مجموعة من البويضات الملفحة، بحيث إذا فشل نمو البويضات التى وضعت فى الرحم، يعاود المحاولة مرة أخرى، دون الحاجة إلى إدخال المنظار مرة أخرى فى بطن المرأة، لشفط المزيد من البويضات ... والبويضة الملفحة جنين صغير، وتركه للموت شبيه بالإجهاض!!

وقد اختلف العلماء بخصوص التعامل مع هذه الأجنة الاحتياطية، هل ترمى؟ أو تجرى عليها التجارب والبحوث؟ أو تحفظ فى ثلاجات وتستخدم فيما بعد؟ وهذا احتمال وارد ولكن 30 - 50% من هذه الأجنة المجمدة تموت فعلاً. إن بعض العلماء يتحدثون عن بداية ال Neurel tube أى الجهاز العصبى، حيث الإحساس فى اليوم الرابع عشر قبل أن يعمل الجهاز العصبى فى اليوم الثانى والأربعين ولكن هل هذا يمنع وجود الجهاز العصبى فى الخلية الأولى، والزيجات من اليوم الأول حتى ولو لم نره؟

إن أهم مشكلتين فى موضوع طفل الأنابيب هما:

- 1- أن لا يكون الحيوان المنوى والبويضة من الزوجين أى أن يكون أحدهما أو كلاهما من آخرين.
- 2- أن يتم التخلص من أجنة صغيرة احتياطية وهذا يشبه الإجهاض تماماً فالخلية الأولى فى الجنين تحمل كل ملامح الطفل المنتظر: الجسد والعقل والنفس والروح ... ونحن لا نقبل أى فكرة تفصل هذه المكونات الأساسية للطبيعة الإنسانية إذ يقول البعض: إن الروح تأتى فيما بعد، أو أن الجنين حتى أربعين يوماً أو مائة يوم يمكن إجهاضه!!
- 3- انحرافات محتملة

- 1- أن يكون الحيوان المنوى أو البويضة من شخص آخر غير الشريك الشرعى ... وأحياناً يكون من المحارم ...
- 2- أن يتم التلقيح من سائل الزوج اصطفاً وقت الابيضاض فى رحم امرأة متبرعة .. وبعد أيام يغسل الطبيب الرحم .. وإذا يعثر على البويضة الملفحة يزرعها فى رحم الزوجة العقيم..
- 3- أن يتم حقن ماء الزوج فى امرأة أخرى ... تحمل وتلد ... ثم تتنازل عن الطفل الذى يدفع ثمنها لذلك طبعاً ... وكثيراً ما حدثت مشاكل قضائية إذ أصررت المرأة صاحبة الرحم المستأجر أن تحتفظ بالطفل متنازلة عن الثمن المادى...
- 4- أن تتم نفس العملية السابقة لكن بماء رجل غريب وليس الزوج لأنه عقيم.
- 5- أحياناً يأخذون البويضة من امرأة غير الزوجة والحيوان المنوى من الزوج والرحم يستأجر من امرأة ثالثة فيكون لهذا الطفل ثلاث أمهات: الأم صاحبة البويضة - الأم صاحبة الرحم - الأم العاقر الزوجة التى دفعت الثمن وتطالب بالطفل.
- 6- وأحياناً يكون الأب عقيماً فيتم أخذ الحيوان المنوى من رجل آخر فيكون للطفل أبوين: مانح الحيوان المنوى + دافع الثمن الذى استلم الطفل.

7- أحياناً تكون الزوجة قد استأصت الرحم لسبب طبي معين، فيتم تلقيح بويضتها من سائل زوجها، ولكن يتم استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى، قد تكون غريبة أو قريبة، أخت أو أم الزوجة .. وفى هذا اختلاط للأنساب إذ تكون أم الطفل هى خالته أو جدته.

8- أحياناً تكون الزوجة بلا رحم، والزوج عقيم فتؤخذ بويضتها وتلقيح بماء غريب، ويوضع الجنين فى رحم مستأجر أو مستعار ويسمى الرحم هنا الرحم الطئر، والأم أماً مستعارة Mother Surrogate.

9- وهذه الحالات تتم إما بالتلقيح الإصطناعى الداخلى أو الخارجى وهى حالات مرفوضة كنسياً، إلا أن الحالة رقم (2)، والتي فيها يكون المنى من الزوج والبويضة من الزوجة، والرحم مستعاراً يعتبرها نوعاً من التبنى!!

وهكذا يقودنا التلقيح الاصطناعى إلى انحرافات كثيرة منها:

1- أن تتحول أرحام النساء إلى **وسيلة تجارة**، مستخدمين المنى المحفوظ، ومن الممكن لسائل رجل واحد تلقيح مائة امرأة كما جاء فى النيوزويك 1985/3/18...

2- **اختلاط الأنساب** ... إذ تكون صاحبة الرحم المستعار أم أو أخت الزوجة... فتكون أم الطفل هى خالته أو جدته...

3- **مجهولية الأنساب** ... حين لا نعرف أصل أو مصدر الحيوان المنوى أو البويضة وهذا شائع جداً فى الغرب.

4- **طفل مولود من زوج ميت** ... حين استخدم سائله المنوى المجد فى تلقيح بويضة زوجته الحية.

5- **استنبات أجنة مجمدة** ... إذ حدث أن تم تكوين جنين من بويضة زوجة وحيوان منوى من الزوج ولكن الزوجين طلبا حفظ الجنين لحين العودة من سفر ... ثم ماتا فى حادث ... وقد حكمت المحكمة فيما بعد بزرع الجنين فى رحم مستأجر.

6- **حمل طبيعى للأم المستعارة** ... فبعد أن اتفق زوجان على استئجار رحم امرأة أخرى مقابل 8000 دولار حملت المرأة المستعارة من زوجها حملاً طبيعياً ... وثبت أن الطفل هو منها ومن زوجها، وليس من الجنين المزروع .. ولما ولد الطفل وحدث النزاع سلمت المرأة الطفل للزوجين الأولين محتفظة بالنقود.

7- **بنوك تجارة المنى** ... لتختار أى امرأة ما تريد من الصفات الوراثية التى تريدها من هذا المنى أو ذاك ...

8- **شركات تأجير الأرحام** ... لزراعة الأجنة فيها ... وماذا عن الأمومة؟ وعن سيطرة المادة على النزعات الإنسانية؟

9- **تلقيح المحارم** ... إذا استخدم المنى فى تلقيح نساء محرمات على الرجل، كشفقته أو خالته ... الخ.

10- **تلقيح غير المتزوجات** ... إذ تستغنى المرأة عن رجل، وتلد طفلاً مستخدمة بنوك المنى.

11- **اختيار جنس الجنين** ... إذ تطلب المرأة منى رجل يحمل صفات الذكورة (Y) أو الأنوثة (X) لتحصل على جنين ذكر أو أنثى كما تريد... وفى هذا احتمال للتدخل فى التوازن الطبيعى بين الذكور والإناث ...

12- **احتمالات الإصابة بالإيدز** أو الأمراض الوراثية أو التشوهات حينما يكون المنى المجد حاملاً لهذه الأمور.

ما المرفوض ... إذن؟

1- استخدام منى من مانع غير الزوج (Donner Sperm)

2- استخدام بويضة من مانحة غير الزوجة (Donner Egg)

3- استعارة رحم فيه خلط للأنساب Surrogate Mother كرحم الأخت أو الجدة أو الخالة ... الخ.

4- استخدام جنين مجمد بعد وفاة الزوجين.

5- تجارة الأجنة المجمدة التى قد تحدث اختلالاً بالتوازن الطبيعى بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى انتهاء إحساس الأمومة والأبوة، إذ قد يتم إنجاب أطفال للدولة وليس لأسرات بعينها، فينشأ أطفال بلا آباء وأمهات وبلا حنان ورعاية إنسانية فتتكون لدينا "مصانع أطفال"!!

وما المقبول .. إذن؟

1- أن يكون المني من الزوج والبويضة من الزوجة مع قيام حياة الزوجية...

2- أن لا يحدث قتل لأجنة احتياطية ...

والحقيقة أن الاطمئنان لذلك صعب للغاية ... لكن المبدأ قائم إذا كان الاطمئنان ممكناً .. وهناك محاولة حالياً أن تراقب هذه العملية (طفل الأنابيب) بواسطة لجان ثقة مكونة من أطباء ورجال دين وشخصيات اعتبارية، للاطمئنان أن عملية التلقيح كانت فعلاً من الزوجين.

؛

ثالثاً

الاستنساخ Cloning

إن قصة النعجة " دوللى " قد شغلت العالم كله ... فترى :

أولاً: ما هو الاستنساخ؟

هو إمكان إنتاج نسخة طبق الأصل من كائن ما، مستخدمين خلية منه، وبويضة من كائن آخر من نفس النوع، ليكونا بمثابة " جنين " يزرع فى رحم مستعار، وينتج لنا هذا المخلوق "النسخة" ..

وتفاصيل العملية كما يلى، آخذين مثال النعجة "دوللى"، التى أنتجها العلماء حديثاً:

- 1- أخذت خلية من ضرع النعجة الفنلندية(أ)
 - 2- هذه الخلية تحمل نسخة من كل الجينات الوراثية والصفات التى تحملها النعجة الفنلندية(أ) ... لذلك تعالج علمياً ...
 - 3- فتتقسم هذه الخلية وتتكاثر منتجة خلايا مشابهة لها ، ثم يوقف انقسامها مؤقتاً ...
 - 4- أخذت بويضة من النعجة الاسكتلندية (ب)
 - 5- حفظت البويضة حية، فى طبق ومحلل معالج علمياً .
 - 6- أزيلت النواة من هذه البويضة .
 - 7- بواسطة شرارة كهربائية تتحد الخلية بالبويضة، فتأخذ البويضة (منزوعة النواة) كل الصفات الوراثية التى للخلية الذببية لكى تنتج جينياً يحمل كل صفات النعجة الفنلندية (أ) .
 - 8- تنمو الخلية وتتكاثر ...
 - 9- يزرع الجنين فى رحم نعجة مستعارة(ج).
 - 10- ولدت النعجة (ج) نعجة صغيرة تحمل كل صفات النعجة (أ) الفنلندية ... نسخة طبق الأصل منها.
- الخلاصة: خلية ناضجة من النعجة (أ) + بويضة منزوعة النواة من النعجة (ب) + التحام كهربائى بينهما ثم زرع فى رحم النعجة (ج) ... فنحصل منها على نسخة طبق الأصل من النعجة (أ)، دون حاجة إلى خلية ذكرية وتناسل...

ثانياً: هل هذا ممكن فى البشر؟

علمياً ونظرياً ... هذا ممكن .. وبدأت أبحاث فعلية فى هذا الميدان ...

بعد أن كادت هذه خيالات علمية فقط، كما نقرأ فى كتاب "عالم جديد شجاع" للكاتب البريطانى "هكسلى"، أو فى رواية "روفك" عن مليونير طلاب أن تكون هناك نسخة طبق الأصل منه فى ابنه ... ولسم الرواية " على صورته "، أو كما جاء فى فيلم " أولاد من البرازيل "، الذى يتحدث عن إنتاج نسخ كثيرة من هتلر!! يجاهد العلم الآن فى أن يجعل هذا الخيال حقيقة ... ونحن لا نعرف إن كان سينجح أم لا ... ولكن علينا أن نستعد لكل الإحتمالات .

ثالثاً: ما هي المشكلات المتوقعة من ذلك ؟

- 1- قد يتصور البعض أن نجاح العلم في استنساخ البشر ... يطعن في وجود الخالق ... ولهذا ينزعج بعض المتدينين ... لكن الحقيقة هي أن العلم يبحث في دائرة المحدودات والمحسوسات، يعكس الدين الذي يهتم - بالإضافة إلى الأمور المادية والزمنية - الأمور اللاهوتية والإيمانية، الى نسميها "الماورائيات"، أى ماذا وراء الطبيعة؟ ماذا وراء الزمن؟ ماذا وراء الموت؟ ... فلا تعارض بين الدين والعلم السليم ...
- 2- بل أن العلم السليم، يدعم الإيمان، لأنه بينما هو يكتشف قوانين الكون والطبيعية والإنسان والوراثة، يدرك أن وراء ذلك كله الخالق العظيم، ومهندس الكون، ومعطى الحياة . فيسجد خاشعاً كما قال نيوتن تعليقاً على اكتشافه لقوانين الطبيعة: "كنت كطفل صغير، يلهو على شاطئ محيط ضخم" أو كما قال أينشتاين: "كلما ازدادت دراسة للكون، ازدادت إحساساً بالجهالة" فهناك الكثير من أسرار الحياة والكون، نكتشفها رويداً رويداً .
- 3- إن كل ما يفعله العلماء، هو الخضوع المطلق لقوانين الكون، والسير في خشوع وراءها، لكي يكتشفوا عوالم وقوانين أخرى جديدة . وهكذا لما عرفوا قوانين الفلك والجاذبية الأرضية والسرعة والزمن، استطاعوا الوصول للقمر ... وما كان لهم أن يخترعوا قوانين جديدة، أو أن يتحدوا القوانين الموضوعية . وحينما سافر رواد الفضاء السبعة في سفينة الفضاء "تشالنجر" (أى المتحدى)، وكان فيها عطل بسيط، سقطت محترقة بكل من فيها، لأنها لم تتواءم مع قوانين الكون، التى وضعها مهندسو الأعظم .
- 4- بل أن - فوق الكل - فهما عرفنا عن الخلية، وتفاعلاتها، وانقساماتها، وجيناتها ، فنحن لا نستطيع أن "نخلق" خلية حية، فالحياة قادمة من ا ، الذى " فيه كانت الحياة " (يو:1: 4) ، والذى نحن به " نحيا ونتحرك ونوجد " (أع:17: 28) ... فـا هو أصل الوجود، ومعطى الحياة وخالفها.
- 5- إن هذه المحاولات لاستنساخ البشر، والتى ربما تنتج، نضعنا أمام تساؤلات كثيرة :
أ- هل ستنتج هذه المحاولات فعلاً ، أن ننسخ صورة طبق الأصل من إنسان ما، مستخدمين خلية منه، مع بويضة منزوعة النواة من امرأة، دون حاجة إلى حيوان منوى !!
ب- هل سينشأ هذا الإنسان "النسخة" عقيماً ؟ أو قابلاً للشيخوخة السريعة ؟
ج- أليس في هذا إلغاء للتناسل؟ فالحاجة للرجل، يكفينا أن نأخذ منه "بذورا إنجابية" ونحفظها في البئز.
د- ماذا عن الشخصية الإنسانية لهذا الإنسان "النسخة"؟ هل سيكون مجرد تشابه بيولوجيا مع متشابه المنسوخ عنه، ثم يكافح عقليا ودينيا بطريقة مختلفة ؟
هـ- وماذا عن الأسرة؟ الحاجة للأسرة هنا، فيكفينا الخلية المحفوظة، والبويضة المأخوذة والرحم المستعار، لنحصل على طفل بلا أب، وبلا أم، وبلا أسرة؟
و- سيكون هناك قطعاً- خلط للأنساب، فمن الممكن أن تطلب أمراه نسخة من أمها المتوفاة، تزرعها في رحمها أو في رحم مستعار أو مستأجر لتحصل على ابنة طبق الأصل من أمها.
ز- ماذا عن غريزتى الأمومة والأبوة .. فى هذه الأحوال؟
ح- ومـاذا عن التوازن الطبيعى بين الجنسين، إذ ربما يطيب للدول أن تنتج ذكورا أكثر من الإناث أو غير ذلك.
ط-الطفل الجديد لن يحمل صفات إلا من أمه فقط، والمشروع أن يأتى الطفل ثمرة زواج مقدس، بين رجل وامرأة، يعطيان من صفاتهما معا للأطفال المولودين منهما.
ي- قد يرى البعض إمكانية أخذ خلية من الزوج العقيم (وليس حيواناً منوياً)، ونجعلها نلتحم ببويضة من الأم، فتعطينا طفلاً كنوع من التبنى، ولكن لا نعرف بأى حال ستكون نفسية هذا الطفل، ولا مدى تقبل الزوج له، وتقبله للزوج، وكيف ستكون العلاقة بين الزوجين إنسانياً

رابعاً: هل من خير محتمل فى الاستنساخ؟

+ بالنسبة للبشر، فقد يأتى الخير من استطاعة العلماء التعامل مع الأمراض، فينتجون أعضاء أو صمامات أو أمصال كما يمكن للهندسة الوراثية العلاج بالجينات أو حتى الوقاية بالجينات من امراض وراثية (حوالى 5000 خطأ أو مرض وراثي تم التعرف عليها جينياً) ...

+ وبالنسبة للحيوانات قد يستطيع العلماء إنتاج سلالات أفضل من الأبقار مثلاً، تنتج ألباناً ذات كفاءة بروتينية عالية ، تصلح للأطفال المبتسرين ... أو لإنتاج مزيد من اللحوم أو الألبان أو الأصواف، أو لمنع حيوان معين من الانفراض ... + وبالنسبة للنبات، قد يتمكن العلماء من إنتاج سلالات تقاوم العطش والملوحة والآفات ...

ختاماً ...

- لا يعترف العلماء بمصداقية أى اكتشاف، ما لم يتم ذلك مرات عديدة وفى أماكن متنوعة مستخدمين نفس المعطيات

....

- قال بروفيسور كورى أن العلماء قد ينجحوا فى استنساخ الإنسان خلال عشر سنوات
- وبدأ علماء أمريكا فى أوريجون استنساخ قرد ... وهو من الثدييات
- ونحن ننتظر ماذا سيفعل الإنسان بالعلم؟ هل سيجعل منه وسيلة لنمو الإيمان وبناء الإنسان، أم وسيلة للدمار وتشويه البشر؟!

إن ا خلق الإنسان حراً، وعليه أن يختار، ويتحمل مسؤولية اختياره، ولقد أعطاه العقل وزنة لخيره، ولكنه يستطيع أن ينحرف بها لتصير شريرة ومدمرة.

إن اكتشاف الطاقة النووية ساعد فى إنتاج الكهرباء من أجل نمو الصناعة، لكن الإنسان انحرف بها للتدمير فى هيروشيما وناجازكى !!!

كما أن نوبل اكتشف الديناميت لإنشاء الطرق ، لكن الإنسان استخدمه فى تدمير نفسه !!!
كذلك فشبكة الإنترنت جاءت لنشر المعلومات البناءة، لكن الإنسان أفسدها إذ وضع عليها أفلاماً مدمرة !!!
أيها الإنسان ... أنظر ... ماذا ستفعل بنفسك، وبغيرك ؟! فليكن العلم فى خدمة الإنسان، لا فى تدميره .